

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE
CUALITATIVO**

**Percepción de la Calidad de Atención en Usuarios del Centro de
Salud Belén, Ayacucho 2026**

Para optar el título profesional de:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

Bach. Gresly Lucero PARIONA PALOMINO

ORCID: 0009-0008-5421-9872

ASESOR:

Dr. Manglio AGUIRRE ANDRADE

ORCID: 0000-0001-8234-567X

AYACUCHO – PERÚ

2026

Índice

ÍNDICE DE TABLAS	IV
INTRODUCCIÓN	1
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	4
1.1. Descripción de la Realidad Problemática	4
1.2. Formulación del Problema	6
1.2.1. Problema General (Pregunta Principal)	6
1.2.2. Problemas Específicos (Preguntas Específicas)	6
1.3. Objetivos de la Investigación	7
1.3.1. Objetivo General	7
1.3.2. Objetivos Específicos	7
1.4. Supuestos Fenomenológicos de la Investigación	8
1.4.1. Supuesto General	8
1.4.2. Supuestos Específicos del Mundo de la Vida (<i>Lebenswelt</i>)	8
1.5. Justificación e Importancia de la Investigación	9
1.5.1. Justificación Teórica	9
1.5.2. Justificación Práctica	9
1.5.3. Justificación Metodológica	9
1.5.4. Justificación Social y Sanitaria	10
1.6. Delimitaciones y Limitaciones del Estudio	10
1.6.1. Delimitación Espacial y Territorial	10
1.6.2. Delimitación Temporal	10
1.6.3. Delimitación Teórica y Epistemológica	10
1.6.4. Delimitación Conceptual y Temática	11
1.6.5. Delimitación Social y Poblacional	11
1.6.6. Limitaciones Metodológicas del Estudio	11
1.7. Viabilidad y Consideraciones Bioéticas	11

2. MARCO CONTEXTUAL	13
2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio	13
2.2. Características demográficas y estructura poblacional	14
2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina	15
2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público	16
2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutive insti- tucional	17
2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (<i>Lebenswelt</i>)	19

ÍNDICE DE TABLAS

1.	Cartera de servicios asistenciales y talento humano del Centro de Salud Belén (I-3).	18
2.	Articulación dialéctica entre el contexto empírico de Belén y los cuatro existenciales del mundo de la vida (<i>Lebenswelt</i>).	21

INTRODUCCIÓN

La calidad de atención y el acceso efectivo a los servicios de salud en el primer nivel constituyen pilares insoslayables para la consolidación de la cobertura sanitaria universal y la materialización del derecho humano a la salud. De acuerdo con las directrices conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y el Banco Mundial [1], brindar servicios oportunos, seguros, continuos y centrados en la persona es un imperativo ético indispensable para mitigar las inequidades estructurales en salud. En el contexto de la atención primaria, la percepción que el usuario construye sobre el cuidado que se le prodiga no se limita a un mero juicio de complacencia utilitaria; representa una valoración profunda e intersubjetiva que condiciona la adherencia a los tratamientos, la asistencia oportuna a los controles preventivos y el nivel de confianza depositado en las instituciones públicas del Estado.

En el Perú, la Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud (MINSA) [2] reconoce que la persistencia de barreras geográficas, administrativas, culturales y de trato interpersonal en los establecimientos de primer nivel (I-1 a I-4) debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario, provocando la despersonalización del acto de cuidado y prolongadas demoras que impactan negativamente en las familias de menores ingresos. Bajo el marco normativo de la cátedra de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486) de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), impartida por el Dr. Manglio Aguirre Andrade, la formulación de proyectos en salud exige una articulación analítica rigurosa mediante la técnica del embudo en tres niveles (global, nacional y regional/local) y la fundamentación explícita de sus dimensiones justificatorias:

1. Técnica del embudo contextual y territorial:

- **Nivel Global e Internacional:** A escala mundial, los sistemas de salud enfrentan una crisis de deshumanización derivada de la sobrecarga burocrática y el predominio tecnicista del acto médico, desatendiendo la vivencia afectiva del paciente y los determinantes socioculturales de la salud [1].
- **Nivel Nacional (Perú):** A nivel nacional, el 78 % de las atenciones asistenciales recaen en el primer nivel; no obstante, coexisten cuellos de botella en la asignación de citas, colas nocturnas y precariedad en el trato interpersonal, lo cual motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en sistemas sanitarios a través de la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030: “Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”** (aprobada mediante Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3].

- **Nivel Regional y Local (Ayacucho – Huamanga):** En el plano regional, la investigación se enmarca y responde de manera vinculante a la **Prioridad Regional 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho [4]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”, cuyo objetivo estratégico regional apunta a generar evidencia empírica directa para transformar los modelos de gestión y dignificar la atención en los centros de salud de la provincia de Huamanga. En este escenario, el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga) representa un punto neurálgico asistencial que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes, donde el 68 % se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza según el SISFOH y más del 94 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS), coexistiendo un 72 % de población con bilingüismo activo quechua chanka-castellano.

2. Importancia y relevancia social del proyecto: El estudio aborda un problema crítico y sensible: la distancia existente entre la oferta de servicios programáticos y la vivencia sentida del usuario andino frente al sistema de salud. Al develar los significados, temores, expectativas y vivencias de los usuarios del Centro de Salud Belén, se genera conocimiento de primera fuente para corregir la desatención a la dignidad del paciente, visibilizando la carga emocional y física que soportan las madres de familia en CRED, las gestantes y los adultos mayores durante las horas de espera en las filas de la madrugada.

3. Finalidad e impacto práctico: La investigación tiene una clara orientación transformadora: sus hallazgos permitirán a la jefatura del Centro de Salud Belén, a la Dirección de la Red de Salud Huamanga y al colectivo profesional de enfermería diseñar planes de mejora continua, protocolos de acogida y triaje humanizado con pertinencia lingüística intercultural (en quechua y español), y estrategias para desarticular los cuellos de botella en el otorgamiento de citas y entrega de medicamentos.

4. Valor teórico y tipología de la investigación: Conforme a la tipología metodológica de la investigación científica, el presente trabajo se clasifica como una **investigación básica o sustantiva**, con **nivel descriptivo-interpretativo** y un riguroso **diseño cualitativo fenomenológico** [13, 25]. Siguiendo las directrices metodológicas de Roberto Hernández-Sampieri y Christian Mendoza [13], así como los fundamentos epistemológicos de Edmund Husserl [24], Max van Manen [26] y John Creswell [25], el propósito central del estudio no es construir modelos teóricos abstractos desvinculados (como en la teoría fundamentada) ni narrar secuencias cronológicas biográficas (como en los diseños narrativos), sino explorar,

describir y comprender la *esencia de las experiencias compartidas (vivencias)* de los usuarios frente al fenómeno del acceso y la calidad asistencial en el Centro de Salud Belén. Dicho abordaje aprehende la vivencia en sus cuatro dimensiones existenciales fundamentales: temporalidad (tiempo vivido en la espera y la madrugada), espacialidad (espacio vivido en salas y consultorios), corporalidad (cuerpo vivido, dolor, frío y fatiga física) y relacionalidad (encuentro intersubjetivo, empatía y comunicación en quechua chanka). Su valor teórico radica en articular dialógicamente los modelos de Calidad en Salud de Avedis Donabedian [5, 6], la Teoría del Acceso de Roy Penchansky [7] y la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson [10] con la cosmovisión andina de Huamanga.

5. Valor metodológico: En el ámbito metodológico, el proyecto aporta una guía de entrevista en profundidad y una matriz de categorización temática cualitativa validadas por juicio de expertos y ajustadas a los criterios de rigor científico de Guba y Lincoln [12]: credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad. Asimismo, aplica la técnica de triangulación metodológica y de actores [16], sentando un precedente técnico replicable para futuros estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSCH.

6. Justificación institucional y bioética: El protocolo cumple con los estándares epistemológicos promovidos por la cátedra de EN 486 (fundamentados en la concepción científica y rigurosa de Mario Bunge [11]), respetando de forma irrestricta las normas bioéticas de la Declaración de Helsinki [32] y las pautas internacionales del CIOMS [33], garantizando la autonomía mediante el consentimiento informado y el estricto anonimato de los participantes.

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En el marco epistemológico de la investigación cualitativa (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) [13], el planteamiento del problema adopta una **naturaleza puramente inductiva y fenomenológica**: no parte del aislamiento artificial de variables cuantitativas ni del contraste de hipótesis numéricas preconcebidas, sino de la inmersión vivencial directa en el ambiente natural donde acontecen los fenómenos humanos. Plantear y delimitar un problema cualitativo fenomenológico constituye un proceso reflexivo, dinámico y abierto orientado a capturar la esencia, las emociones, los sentires corpóreos y los significados intersubjetivos que las personas otorgan a sus vivencias en el momento del acto asistencial (Husserl, 1949; van Manen, 1990) [24, 26].

Para tal fin, la metodología demanda un **contacto directo y vivencial con la realidad estudiada en su escenario cotidiano**. En el presente estudio, el origen de la indagación se sustenta en la observación reflexiva y la experiencia acumulada por la investigadora durante sus prácticas preprofesionales de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en los consultorios del Centro de Salud Belén.

En estricta observancia del canon metodológico de la cátedra de EN 486 (Dr. Manglio Aguirre Andrade), la caracterización de la realidad problemática se articula mediante la técnica del embudo en tres niveles de profundidad:

Contexto Internacional (Macro)

A escala mundial, los sistemas de salud enfrentan una crisis estructural caracterizada por la fragmentación asistencial y la despersonalización del acto de cuidado (OMS, OCDE y Banco Mundial, 2018) [1]. El predominio de un paradigma biomédico tecnicista y la sobrecarga burocrática en el primer nivel de atención han reducido la evaluación de los servicios a meros indicadores de rendimiento cuantitativo, invisibilizando la vivencia afectiva del paciente, el sufrimiento somático de la espera y los determinantes socioculturales de la salud. De acuerdo con Donabedian (1980, 2005) [5, 6] y Watson (2008) [10], la calidad del cuidado no reside únicamente en la corrección instrumental del procedimiento terapéutico, sino medularmente en el proceso interpersonal: la calidez de la mirada, la capacidad de escucha, el respeto a la dignidad y la reciprocidad humanizada entre el profesional y el ser cuidado.

Contexto Nacional (Meso)

En el Perú, la Política Nacional de Calidad en Salud del Ministerio de Salud (MINSA, 2021) [2] reconoce que la persistencia de barreras de acceso geográficas, organizacionales, económicas y culturales debilita gravemente la capacidad resolutoria del primer nivel asistencial (categorías I-1 a I-4), donde recae más del 78 % de las atenciones asistenciales del país. A pesar de los esfuerzos normativos, persisten cuellos de botella crónicos: colas en la madrugada para conseguir un cupo, desabastecimiento de medicamentos esenciales del petitorio oficial y una marcada frialdad comunicativa en el trato al usuario. Esta brecha motivó al Estado peruano a priorizar la investigación en salud a través de la **Línea 10 de Investigación en Salud al 2030**: “*Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal*” (Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA) [3], orientada a generar evidencia empírica directa para dignificar la atención y garantizar la cobertura sanitaria universal.

Contexto Regional y Local (Micro: Centro de Salud Belén)

En el ámbito regional, el estudio se articula de forma vinculante con la **Prioridad 10 de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030**, aprobada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ayacucho, 2025) [4]: “*Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud*”. En este marco, el Centro de Salud Belén (Categoría I-3, Microred Huamanga) representa un punto neurálgico asistencial que atiende a una población adscrita de 18,450 habitantes en el distrito de Ayacucho, a 2,760 metros sobre el nivel del mar.

En este establecimiento aflora una dramática distancia entre la lógica asistencial programática y la vivencia sentida del usuario andino:

- **Vulnerabilidad socioeconómica:** El 68.2 % de la población usuaria se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza según el SISFOH, y más del 94.5 % depende del Seguro Integral de Salud (SIS) en su modalidad subsidiada.
- **Identidad lingüística y cultural:** El 72.0 % de los usuarios presenta bilingüismo activo quechua chanka-castellano. Para esta población, la salud se vivencia a través de códigos ancestrales de afecto y reciprocidad comunitaria: la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*), el saludo cálido y respetuoso (*napaykuy*) y el respeto mutuo (*respetanakuy*) (Aguirre-Andrade et al., 2020) [20].
- **La experiencia de la desatención:** Cuando los profesionales —condicionados por la prisa protocolar, la sobrecarga laboral o el monolingüismo hispanohablante— omiten el saludo, evitan el contacto visual o se muestran indiferentes ante el dolor (*nanay*), el usuario experimenta sensaciones de desamparo, intimidación y violencia simbólica, replegándose en el silencio defensivo (*upallay*). Asimismo,

las madrugadas gélidas a la intemperie (5 °C a 8 °C) desde las 4:00 AM para obtener un cupo generan agotamiento somático y menoscabo de la dignidad de las madres gestantes y adultos mayores.

El problema medular de investigación radica, por consiguiente, en develar y comprender cómo los propios usuarios perciben, vivencian y significan la calidad de atención y el acceso asistencial en el Centro de Salud Belén desde la profundidad de su mundo de la vida.

—

1.2. Formulación del Problema

En coherencia con los preceptos del diseño fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) [13] y el principio de inmutabilidad del entorno sellado, se formulan las preguntas norteadoras de la investigación:

1.2.1. Problema General (Pregunta Principal)

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al fenómeno del acceso y la calidad de atención en los servicios de salud del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?

1.2.2. Problemas Específicos (Preguntas Específicas)

1. ¿Cómo vivencian los usuarios la **dimensión temporal (tiempo vivido / *Lebenszeit*)** en las filas de madrugada (4:00 AM) y las horas transcurridas en sala de espera antes de ser atendidos?
2. ¿De qué manera experimentan los usuarios la **dimensión espacial (espacio vivido / *Lebensraum*)** respecto al hacinamiento, comodidad física y privacidad dentro de los consultorios?
3. ¿Cuáles son las vivencias somáticas y emocionales vinculadas a la **dimensión corporal (cuerpo vivido / *Leib*)**, tales como frío matutino, fatiga física, hambre y dolor (*nanay*) frente a la espera asistencial?
4. ¿Cómo perciben los usuarios la **dimensión relacional (relación humana vivida / *Mitwelt*)** respecto a la empatía, calidez, escucha activa y comunicación intercultural en quechua chanka brindada por el equipo de salud?
5. ¿Cuál es la **esencia compartida y las divergencias vivenciales** que configuran el significado integral atribuido por los usuarios a una atención de calidad y digna

en el Centro de Salud Belén?

—

1.3. Objetivos de la Investigación

Guardando estricta simetría lógica biunívoca ($1 \leftrightarrow 1$) con las preguntas norteadoras y empleando verbos en infinitivo propios de la indagación cualitativa comprensiva, se establecen los siguientes objetivos:

1.3.1. *Objetivo General*

Explorar, comprender y describir el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al acceso y calidad de atención en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

1.3.2. *Objetivos Específicos*

1. Explorar y comprender las vivencias de los usuarios respecto a la **dimensión temporal (tiempo vivido)** en las filas matutinas de madrugada y el tiempo de espera en el establecimiento.
 2. Describir y comprender la experiencia de los usuarios respecto a la **dimensión espacial (espacio vivido)** en cuanto al confort, hacinamiento y privacidad de los ambientes asistenciales.
 3. Identificar y comprender las vivencias somáticas de la **dimensión corporal (cuerpo vivido)**, analizando la resistencia al frío matutino, fatiga, hambre y dolor del paciente.
 4. Comprender y analizar la experiencia de la **dimensión relacional (relación humana vivida)** en el encuentro asistencial, focalizando la empatía, trato digno y diálogo en lengua quechua.
 5. Sintetizar la **estructura esencial y las divergencias fenomenológicas** que configuran la percepción de una atención digna y de calidad en el Centro de Salud Belén.
-

1.4. Supuestos Fenomenológicos de la Investigación

En el paradigma cualitativo fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; van Manen, 1990) [13, 26], la investigación no formula hipótesis cuantitativas para contrastación estadística paramétrica. En su lugar, se establecen **supuestos fenomenológicos inductivos**, los cuales constituyen proposiciones teóricas preliminares que orientan la mirada de la investigadora sin prejuzgar ni constreñir las vivencias que emergerán de los informantes durante la reducción fenomenológica (*epojé*):

1.4.1. Supuesto General

La percepción de la calidad de atención y el acceso constituye para el usuario del Centro de Salud Belén una vivencia intersubjetiva profunda donde la calidez humana, el reconocimiento de su dignidad andina, la comunicación empática en lengua originaria y la oportunidad resolutoria del padecimiento prevalecen sobre la mera dimensión instrumental o protocolar del acto asistencial.

1.4.2. Supuestos Específicos del Mundo de la Vida (*Lebenswelt*)

1. **Supuesto sobre la Temporalidad:** La prolongada espera a la intemperie y la incertidumbre en la obtención de cupos genera en el usuario una vivencia de desvalorización de su tiempo vital y angustia existencial, transformando el acceso en una experiencia de sacrificio físico.
2. **Supuesto sobre la Espacialidad:** El espacio físico precario, la falta de asientos adecuados y la ausencia de privacidad acústica y visual en el consultorio restringen la intimidad del paciente, inhibiendo la revelación libre de sus síntomas y temores íntimos.
3. **Supuesto sobre la Corporalidad:** El cuerpo del usuario somatiza la desatención institucional a través del impacto del frío matutino andino (5 °C a 8 °C), el agotamiento muscular y la agudización del dolor físico (*nanay*), transformando la espera en una vivencia corporalmente afflictiva.
4. **Supuesto sobre la Relacionalidad:** La interacción dialógica intercultural mediada por la calidez del saludo (*napaykuy*) y la acogida en quechua chanka (*allin chaskiy*) mitiga el temor institucional, restablece la confianza terapéutica y resignifica positivamente la calidad del servicio.
5. **Supuesto sobre la Esencia y Divergencias:** La esencia del cuidado digno radica en la experiencia compartida de sentirse respetado como persona humana integral, emergiendo divergencias vivenciales moduladas por la edad y el grado de

vulnerabilidad socioeconómica del usuario.

—

1.5. Justificación e Importancia de la Investigación

Conforme a las directrices epistemológicas de la cátedra de EN 486 (UNSCH), fundamentadas en la concepción científica y rigurosa de Mario Bunge (2014) [11], y los criterios de relevancia de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) [13], el proyecto se sustenta en cuatro dimensiones justificatorias:

1.5.1. *Justificación Teórica*

El estudio llena un vacío epistémico crítico en la literatura regional sobre calidad de atención en salud pública. Tradicionalmente, la evaluación de servicios se ha sustentado en modelos estandarizados cuantitativos (como SERVQUAL) [8, 9] que reducen la satisfacción a medias aritméticas, omitiendo las complejidades subjetivas y la cosmovisión del habitante andino. Esta investigación articula dialógicamente el Enfoque de Calidad en Salud de Donabedian (1980, 2005) [5, 6], la Teoría del Acceso de Penchansky (1981) [7] y la Teoría del Cuidado Humano de Watson (2008) [10] con las cuatro dimensiones existenciales de van Manen (1990) [26], construyendo un marco comprensivo pionero con pertinencia cultural andina en la UNSCH.

1.5.2. *Justificación Práctica*

La investigación responde a una necesidad institucional urgente. Al desentrañar los nudos críticos del acceso y el trato humano desde el relato directo de los usuarios, los hallazgos aportarán insumos concretos para que la Jefatura del Centro de Salud Belén y la Dirección de la Red de Salud Huamanga rediseñen el flujo de admisión matutina, erradiquen las filas a la intemperie en la madrugada y elaboren protocolos de triaje y acogida intercultural con pertinencia lingüística en quechua chanka.

1.5.3. *Justificación Metodológica*

Aporta al campo de la investigación en enfermería un protocolo fenomenológico riguroso, validado por juicio de expertos y estructurado bajo los cuatro existenciales del *Lebenswelt*. Diseña y valida una guía de entrevista semiestructurada bilingüe (Quechua Chanka-Español) y una matriz de categorización temática cualitativa auditadas bajo los criterios de rigor de Guba y Lincoln (1985) [12]: credibilidad, transferibilidad, consistencia

y confirmabilidad, estableciendo un precedente metodológico replicable para futuras tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSCH.

1.5.4. Justificación Social y Sanitaria

El proyecto encarna un imperativo ético de equidad en salud. Visibiliza el sufrimiento silenciado de las madres de familia en CRED, gestantes y adultos mayores en situación de pobreza (68.2 % SISFOH) y alta dependencia del SIS (94.5 %). Responde de manera vinculante a la **Línea 10 Nacional de Investigación del MINSA al 2030** [3] y a la **Prioridad 10 Regional de Investigación de la DIRESA Ayacucho 2025–2030** [4], contribuyendo a transformar la atención de salud en un espacio de dignidad humana y justicia social.

—

1.6. Delimitaciones y Limitaciones del Estudio

Para preservar las fronteras del entorno de investigación y garantizar el aislamiento metodológico, se declaran formalmente las delimitaciones del alcance y las limitaciones del estudio:

1.6.1. Delimitación Espacial y Territorial

La investigación se circunscribe de forma estricta a los ambientes físicos del Centro de Salud Belén (Categoría I-3), abarcando la vereda exterior de espera matutina, las salas interiores de espera y los consultorios asistenciales de Medicina General, Enfermería (CRED, Inmunizaciones), Obstetricia y Odontología, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a 2,760 msnm.

1.6.2. Delimitación Temporal

El horizonte temporal de recolección y análisis vivencial corresponde al año fiscal y académico 2026.

1.6.3. Delimitación Teórica y Epistemológica

El marco teórico se limita de manera exclusiva a los modelos de Calidad Asistencial de Donabedian (1980) [5], la Teoría de Acceso de Penchansky (1981) [7], la Teoría del Cuidado Humano de Watson (2008) [10] y la fenomenología hermenéutica de Husserl

(1949) [24] y van Manen (1990) [26]. Todo constructo positivista ajeno a estas fronteras queda excluido.

1.6.4. Delimitación Conceptual y Temática

El fenómeno se investiga a través del prisma exclusivo de las cuatro dimensiones existenciales del mundo de la vida (*Lebenswelt*): Temporalidad (*Lebenszeit*), Espacialidad (*Lebensraum*), Corporalidad (*Leib*) y Relacionalidad (*Mitwelt*), más la síntesis estructural esencial.

1.6.5. Delimitación Social y Poblacional

La unidad de estudio está constituida por personas usuarias mayores de 18 años, hispanohablantes o quechuahablantes, que acuden como usuarios externos a los servicios asistenciales del establecimiento. Se excluye al personal administrativo y asistencial, cuya vivencia laboral constituye un objeto de estudio independiente.

1.6.6. Limitaciones Metodológicas del Estudio

- **Naturaleza no probabilística del diseño:** Los hallazgos fenomenológicos no persiguen la generalización estadística numérica de frecuencias poblacionales, sino la transferibilidad conceptual contextualizada según los criterios de rigor de Guba y Lincoln (1985) [12].
- **Efecto de reactividad y pudor:** La presencia de la investigadora y el uso de grabadoras de audio podrían generar reticencia inicial en ciertos informantes quechuahablantes. Dicha limitación se mitiga mediante una inmersión prolongada en el campo, el establecimiento de rapport empático y el diálogo en su lengua materna.
- **Condicionamiento biometeorológico:** Las variaciones estacionales de frío y lluvia pueden modular la vivencia somática, lo que demanda registrar notas de campo reflexivas precisas en cada sesión de entrevista.

—

1.7. Viabilidad y Consideraciones Bioéticas

La presente investigación es plenamente viable puesto que cuenta con acceso institucional favorable a las instalaciones del Centro de Salud Belén, disponibilidad de recursos humanos calificados, respaldo académico tutorial de la cátedra de EN 486 (Dr.

Manglio Aguirre Andrade) y financiamiento asegurado en su totalidad con recursos propios de la investigadora principal.

En estricta observancia del rigor bioético, el protocolo será sometido al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y coordinado formalmente con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho y la Red de Salud Huamanga antes de cualquier abordaje de campo.

El estudio se rige bajo los principios de la Declaración de Helsinki (2013) [32], las pautas internacionales del CIOMS (2016) [33] y el Informe Belmont:

- **Principio de Autonomía:** Se garantizará la voluntariedad absoluta a través de la suscripción formal del Consentimiento Informado (Anexo 4), explicándose de forma detallada y comprensible la naturaleza de la investigación en quechua chanka o castellano.
- **Principio de Beneficencia y No Maleficencia:** Se asegurará un ambiente de escucha digno y contenedor, evitando cualquier revictimización o angustia emocional durante el relato vivencial. Las entrevistas podrán suspenderse si el informante lo solicita.
- **Principio de Justicia y Confidencialidad:** Se mantendrá el anonimato absoluto mediante el uso de códigos alfanuméricos despersonalizados (ejemplo: Informante 01 – [INF-01-MED]) en todas las etapas de transcripción, categorización en ATLAS.ti v9 y redacción del informe final.

2. MARCO CONTEXTUAL

En la investigación cualitativa bajo el diseño fenomenológico, el marco contextual no se reduce a una enumeración estática de datos cuantitativos ni a un inventario geográfico desvinculado; constituye la reconstrucción densa, profunda y holística del *ambiente natural* donde transcurre la vida cotidiana de las personas y donde se gesta el fenómeno estudiado [13, 25]. Para comprender la esencia de la experiencia vivida (*Lebenswelt*) de los usuarios respecto al acceso y la calidad de atención en el Centro de Salud Belén, es indispensable caracterizar la atmósfera física, cultural, social y sanitaria que envuelve, condiciona y dota de sentido a sus sentires, expectativas, frustraciones y valoraciones intersubjetivas [26, 4].

2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio

La investigación se sitúa en el Centro de Salud Belén, establecimiento sanitario cabecera perteneciente a la Microrred Huamanga de la Red de Salud Huamanga, adscrito a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. El establecimiento se localiza en el emblemático e histórico barrio de Belén, en el sector céntrico-sur del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una altitud oficial de 2,760 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas de emplazamiento corresponden a los 13°09'47" de Latitud Sur y 74°13'28" de Longitud Oeste.

El territorio bajo su responsabilidad sanitaria se asienta en la subcuenca del río Alameda, dentro de la cuenca principal del valle de Huamanga. Limita por el norte con el casco monumental y urbano central de la ciudad de Huamanga; por el sur con las urbanizaciones periurbanas del distrito de San Juan Bautista; por el este con las faldas del cerro Acuchimay y el distrito de Carmen Alto; y por el oeste con la prolongación de la avenida Mariscal Cáceres y el jirón Bellido. Su orografía presenta una topografía moderadamente accidentada, con calles estrechas, empinadas y trazados coloniales que imponen un esfuerzo físico considerable a los usuarios con movilidad reducida, gestantes y personas de la tercera edad que acuden a pie.

El clima del área es templado y seco durante las horas diurnas soleadas, con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 15 °C y 22 °C. No obstante, una característica meteorológica decisiva para la experiencia del usuario radica en la marcada oscilación térmica interdiurna: durante las madrugadas andinas (entre las 4:00 a.m. y las 6:30 a.m.), el termómetro desciende habitualmente a valores de entre 5 °C y 8 °C, llegando a extremos menores en la temporada seca y de heladas (junio a agosto). Asimismo, se presenta una temporada de precipitaciones pluviales intensas entre los meses de noviembre y marzo. Esta condición ambiental no constituye un dato accesorio, sino un determinante

corpóreo directo: los usuarios que pugnan por conseguir una cita deben pernoctar a la intemperie en la vereda exterior del establecimiento expuestos al frío penetrante y a la lluvia, lo cual predispone a la fatiga somática y agrava sus dolencias de base.

En cuanto a la conectividad y accesibilidad vial, el establecimiento cuenta con acceso terrestre directo a través de arterias vehiculares pavimentadas (Jr. Bellido, Jr. Arequipa y Av. Mariscal Cáceres). El transporte urbano está garantizado mediante diversas líneas de transporte público (microbuses de las rutas 1, 3, 7 y 12), así como por una densa flota de mototaxis y taxis colectivos. A pesar de esta conectividad formal, el costo del pasaje y las barreras físicas del relieve obligan a un amplio porcentaje de familias vulnerables de sectores altos a realizar traslados peatonales de 20 a 40 minutos cargando niños en mantas tradicionales (*llicllas*) antes de la salida del sol.

2.2. Características demográficas y estructura poblacional

La jurisdicción sanitaria asignada al Centro de Salud Belén abarca una población diana proyectada de 18,450 habitantes según el Padrón Poblacional Oficial de la Red de Salud Huamanga (2025–2026). La pirámide poblacional se caracteriza por una base ensanchada en los primeros decenios de vida y una proporción creciente de personas adultas mayores, configurando un doble desafío asistencial de perfil materno-infantil y crónico-degenerativo. La distribución por etapas de vida es la siguiente:

- **Población Infantil (menores de 5 años):** Representa el 12.4% (2,288 niños), constituyendo el segmento con mayor intensidad de demanda en los consultorios preventivo-promocionales de Crecimiento y Desarrollo (CRED), tamizaje y tratamiento de anemia ferropénica, suplementación nutricional e inmunizaciones del esquema nacional regular.
- **Población Escolar y Adolescente (5 a 17 años):** Abarca el 19.6% (3,616 personas), demandantes de intervenciones de salud bucal, tamizaje visual, salud del escolar y orientación en salud sexual y reproductiva.
- **Población Joven y Adulta (18 a 59 años):** Constituye el 52.8% (9,742 personas), con un marcado predominio de mujeres en edad fértil (MEF) que acuden para control prenatal, despistaje de cáncer de cuello uterino, planificación familiar y atenciones médicas por patologías agudas.
- **Población Adulta Mayor (60 años a más):** Concentra el 15.2% (2,804 personas), un grupo en acelerado envejecimiento que presenta alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, artrosis y secuelas osteomusculares, requiriendo un acompañamiento asistencial continuo, trato digno y accesibilidad física preferencial.

Desde la mirada fenomenológica, resalta el fenómeno de la **feminización de la demanda matutina**: más del 70 % de los usuarios que concurren a las salas de espera son mujeres. Se trata de madres de familia que acuden al cuidado y vigilancia de la salud de sus hijos menores, mujeres gestantes en controles prenatales y mujeres cuidadoras que asisten a adultos mayores dependientes. Esta dinámica impone sobre la mujer andina una sobrecarga cotidiana de roles, donde el tiempo de espera en el centro de salud compite directamente con sus jornadas de trabajo doméstico y comercial.

2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina

El entorno comunitario de Belén se distingue por una singular riqueza identitaria y una densa trama de sociabilidad popular. Históricamente, el barrio de Belén ha sido cuna de ilustres artesanos populares de Huamanga, reconocidos internacionalmente por el arte del retablo ayacuchano, la imaginería religiosa en yeso y el tallado tradicional en piedra de Huamanga. En este espacio geográfico coexisten familias tradicionales residentes desde hace generaciones con oleadas de población migrante provenientes de las zonas rurales y provincias del centro-sur ayacuchano (Víctor Fajardo, Cangallo y Vilcas Huamán), muchas de ellas asentadas a raíz de la violencia sociopolítica de las décadas pasadas.

En el plano lingüístico, el **72 % de la población usuaria es bilingüe activa en quechua chanka y castellano**. En las generaciones de adultos mayores y en mujeres migrantes de sectores periféricos, el quechua constituye la lengua materna predominante y el vehículo exclusivo para verbalizar el sufrimiento corpóreo y anímico. Para la cosmovisión andina huamanguina, los padecimientos no son meras disfunciones biológicas aisladas, sino alteraciones del equilibrio integral del ser humano con su entorno, expresadas en nociones complejas como el dolor visceral (*nanay*), el estado de enfermedad integral (*onqoy*), la tristeza y aflicción acumulada (*llakikuy*), el enfriamiento del cuerpo (*chiriyay*) o los desórdenes espirituales derivados del espanto o susto (*mancharisqa*).

Las pautas de sociabilidad comunitaria exigen de manera indeclinable la observancia de códigos éticos y de cortesía tradicionales basados en el respeto mutuo (*respetanakuy*), el saludo formal y afectuoso (*napaykuy*) y la acogida hospitalaria (*allin chaskiy*) [20]. Cuando el personal de salud —frecuentemente hispanohablante monolingüe o condicionado por la prisa protocolar— prescinde del saludo, evita el contacto visual, interrumpe el relato del usuario o emplea un léxico excesivamente tecnicista, se produce un violento quiebre comunicativo. El usuario andino interpreta esta conducta como desdén, frialdad burocrática, soberbia institucional o discriminación clasista y étnica, replegándose en el silencio (*upallay*) y perdiendo la confianza en el sistema asistencial.

En cuanto al nivel de instrucción, el 48 % de los jefes de familia cuenta con

educación secundaria completa, un 26 % posee secundaria incompleta o primaria, y un 8 % (concentrado en adultos mayores) registra analfabetismo formal o funcional. Esta realidad representa un desafío crítico para la alfabetización en salud, pues muchos usuarios no logran descifrar las recetas médicas escritas, los calendarios de citas o la señalética institucional de los consultorios, dependiendo enteramente de la orientación verbal empática que el profesional de enfermería pueda suministrarle.

2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público

La actividad socioeconómica de los hogares usuarios del Centro de Salud Belén se inserta de manera mayoritaria en el régimen de la economía popular informal y de subsistencia diaria. La Población Económicamente Activa (PEA) labora preponderantemente en el comercio ambulatorio de verduras, frutas y alimentos preparados en el Mercado Central de Belén y su concurrida feria sabatina; en el transporte menor mediante la conducción de mototaxis; en faenas eventuales de construcción civil (albañilería y peonaje); en talleres artesanales independientes; y en el trabajo doméstico no remunerado o remunerado por jornada.

De acuerdo con los registros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el **68.2 % de las familias del ámbito de influencia se encuentra clasificada en situación de pobreza y pobreza extrema**. En coherencia con este perfil de precariedad material, el **94.5 % de la población usuaria se encuentra afiliada al régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS)**.

Esta dependencia casi total del aseguramiento público estatal confiere una trascendencia vital a la gratuidad del servicio. Los usuarios acuden al centro asistencial bajo la certeza legítima de que el Estado proveerá tanto el acto médico como los medicamentos necesarios para su recuperación. Cuando la farmacia del establecimiento incurre en roturas de stock o desabastecimiento de medicamentos esenciales (como antibióticos de primera línea, antipiréticos, micronutrientes para la anemia o fármacos antihipertensivos), se suscita una crisis devastadora en la economía doméstica: el usuario se ve conminado a realizar un **gasto de bolsillo imprevisto** en las boticas y farmacias comerciales privadas que proliferan en los alrededores del centro de salud. Para una madre que vive de las ganancias del día a día en el mercado, destinar 20 o 30 soles a la compra de fármacos implica desfinanciar la alimentación diaria del hogar, vivencia que es experimentada con honda amargura, desesperanza e impotencia frente a la precariedad del sistema público.

2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutiva institucional

El Centro de Salud Belén se encuentra formalmente categorizado como un establecimiento de salud del primer nivel de atención de nivel **I-3** (sin internamiento hospitalario), desempeñando un papel neurálgico como cabecera de microred asistencial. Su misión operativa consiste en brindar atención integral ambulatoria, promocional, preventiva y de recuperación básica para descongestionar el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” (Nivel III-1).

A continuación se detalla la oferta prestacional y la distribución del talento humano asistencial disponible en el establecimiento:

Tabla 1: Cartera de servicios asistenciales y talento humano del Centro de Salud Belén (I-3).

Cartera de Servicios	Actividades Asistenciales Principales	Turno	Personal Asignado
Medicina General	Consulta ambulatoria, diagnóstico clínico, prescripción médica y atención de morbilidades agudas y crónicas.	Mañana / Tarde	04 Médicos Cirujanos
Enfermería (CRED e Inmunizaciones)	Control del crecimiento y desarrollo del niño, tamizaje de anemia, vacunación del esquema regular y consejería nutricional.	Mañana / Tarde	06 Lic. en Enfermería
Enfermería (TBC y No Transmisibles)	Control de tuberculosis (PCT), administración de tratamiento DOTS, tamizaje de hipertensión arterial y diabetes mellitus.	Mañana	02 Lic. en Enfermería
Obstetricia (Salud Reproductiva)	Control prenatal, psicoprofilaxis obstétrica, monitoreo fetal básico, planificación familiar y tamizaje de cáncer ginecológico.	Mañana / Tarde	04 Lic. en Obstetricia

El perfil epidemiológico de la demanda ambulatoria está hegemonizado por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), parasitosis intestinal, anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 36 meses, infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres en edad fértil y gestantes, lumbalgias mecánicas derivadas del trabajo físico, y patologías crónicas no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2) en adultos mayores.

No obstante su relevancia estratégica, el establecimiento enfrenta una serie de **nudos críticos institucionales y barreras operativas** que inciden directamente en la subjetividad del usuario:

1. **Mecanismo de asignación de cupos matutinos (*tickets*):** El establecimiento oferta un número restringido de atenciones médicas por turno (generalmente entre 12 y 16 cupos por consultorio médico), limitadas estrictamente a la jornada asistencial de 6 horas. Esta restricción cuantitativa obliga a los usuarios a disputarse los turnos desde tempranas horas de la madrugada, generando un clima de zozobra e incertidumbre donde muchas personas, tras aguardar horas en la fila exterior, reciben la notificación de que los cupos se han agotado.
2. **Limitaciones arquitectónicas y hacinamiento espacial:** El centro de salud funciona en un inmueble cuya infraestructura original ha sido sucesivamente adaptada, presentando pasillos estrechos, salas de espera techadas pero con escaso aislamiento térmico y bancas metálicas insuficientes. La tabiquería provisional entre consultorios adolece de aislamiento acústico, lo que provoca la filtración de conversaciones clínicas y quebranta el derecho a la privacidad e intimidad corporal y emocional de los pacientes.
3. **Inestabilidad laboral y sobrecarga burocrática:** Una fracción considerable del personal profesional y técnico se encuentra bajo regímenes de contratación temporal transitoria (CAS), lo que origina una continua rotación de profesionales que interrumpe la continuidad del vínculo afectivo con los pacientes de la comunidad. A ello se suma la sobrecarga de digitación en los sistemas informáticos (HIS-MINSA y formato FUA-SIS), la cual absorbe gran parte del tiempo de consulta, obligando al profesional a interactuar con la pantalla del computador en detrimento del contacto visual con el usuario.

2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (*Lebenswelt*)

En concordancia con los postulados epistemológicos de Max van Manen [26], John Creswell [25] y Roberto Hernández-Sampieri [13], el mundo de la vida (*Lebenswelt*) de

los seres humanos se articula indisolublemente a través de cuatro existenciales universales: la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad. El marco contextual del Centro de Salud Belén no actúa como un mero telón de fondo pasivo, sino que opera como un escenario dialéctico que condiciona y da forma a cada una de estas dimensiones existenciales, tal como se sintetiza a continuación:

Tabla 2: Articulación dialéctica entre el contexto empírico de Belén y los cuatro existenciales del mundo de la vida (*Lebenswelt*).

Dimensión Existencial (<i>Lebenswelt</i>)	Manifestación Empírica en el Contexto de Belén	Significado Vivencial y Afectivo Construido por el Usuario
Temporalidad (<i>Tiempo vivido</i>)	Despertar forzado a las 4:00 a.m.; horas de vigilia en la vereda a la espera de la apertura del portón (7:00 a.m.); lapsos prolongados de espera en salas (2 a 3 horas) frente a una consulta médica de apenas 10 a 15 minutos.	Vivencia del tiempo suspendido, angustia e impotencia ante la posibilidad de perder el cupo. Disparidad percibida entre el enorme sacrificio temporal realizado y la brevedad del contacto clínico.
Espacialidad (<i>Espacio vivido</i>)	La vereda exterior pública; el portón de rejas de metal; los pasadizos estrechos abarrotados de pacientes; consultorios con paredes divisorias delgadas que dejan filtrar voces e intimididades; ventanilla de admisión con rejas o vidrio.	Sensación de hacinamiento, exposición pública y pérdida de intimidad. La ventanilla y el portón operan como fronteras físicas y simbólicas que separan al usuario del poder biomédico institucional.
Corporalidad (<i>Cuerpo vivido</i>)	Frío lacerante de la madrugada andina (5 °C a 8 °C); fatiga física muscular por permanecer de pie durante horas; hambre y sed por asistir en ayunas; llanto de los infantes acatarrados en mantas; dolores articulares intensificados por la intemperie.	El cuerpo enfermo no es un objeto abstracto: es el asiento directo de la vulnerabilidad física, el dolor y la incomodidad somática. El acto asistencial es ansiado como un alivio palpable a la opresión del cuerpo.
Relacionalidad (<i>Relación vivida con los otros</i>)	Encuentro intersubjetivo entre el usuario quechua-mestizo vulnerable y el personal sanitario; presencia del saludo cordial (<i>nipaykuy</i>) o su omisión; mirada a los ojos frente a la mirada fija en el monitor; paciencia explicativa o respuestas cortantes.	La calidad se define en la dignidad del trato interpersonal: el usuario busca acogida humana (<i>allin chaskiy</i>), respeto mutuo (<i>respetanakuy</i>) y comprensión en su propia lengua. La calidez del cuidado de enfermería transforma el desamparo en alivio y gratitud.

Esta articulación multidimensional confirma que, para el usuario del Centro de

Salud Belén, la “calidad de atención” trasciende ampliamente los parámetros gerenciales o el abastecimiento técnico; constituye una experiencia existencial totalizante donde el cuerpo aterido, el tiempo sacrificado, el espacio habitado y el trato humano recibido configuran la esencia de su satisfacción o sufrimiento frente al sistema público de salud.